

# DIE JURI-JANOVSKI-THESE ZUR GEBURT

Juri Janovski · 9. September 2026

**Die bestmögliche Geburtshilfe verbindet einen von der Frau selbst gesteuerten, ruhigen, warmen und gedämpft beleuchteten Raum - auf Wunsch mit Musik oder Stille - mit jederzeit verfügbarer Hebammenhilfe und klinischer Sicherheit.**

**CODE: DRUCK SENKEN | SELBSTBESTIMMUNG ERHÖHEN | SICHERHEIT SICHERN**

## DIE FRAGE AN DIE WELT

Verbessert ein von der Frau kontrolliertes, reizarmes Geburtsumfeld gegenüber der üblichen Versorgung bei vergleichbarer medizinischer Betreuung nachweisbar ihre **Selbstbestimmung und ihr Geburtserleben**, ohne die Sicherheit von Mutter oder Kind klinisch relevant zu verschlechtern?

## WAS „BESSER“ BEDEUTET

1 · Erfahrung: mehr Kontrolle, Geborgenheit und ein besseres Geburtserleben.

2 · Sicherheit: keine klinisch relevante Verschlechterung für Frau oder Kind.

Gemessen werden unter anderem Angst, Stress, Schmerz, Medikamentenbedarf, Wehenförderung, Geburtsdauer, Eingriffe, Blutverlust und der Zustand des Kindes. Nach 6 Wochen und 3 Monaten folgen validierte Messungen geburtsbezogener Belastung und depressiver Symptome. Medizinisch notwendige Hilfe ist kein Misserfolg.

## DIE FRAU STEUERT DEN RAUM

Licht, Geräusche, Musik oder Stille, Bewegung, Privatsphäre und gewünschte Begleitung bleiben veränderbare Entscheidungen der Frau.

„Kerzen“ stehen für Atmosphäre: Kliniken nutzen dimmbare, flammenlose Leuchten. Untersuchungs- und Notfalllicht ist sofort verfügbar. Wärme, Monitoring und medizinische Hilfe bleiben gesichert.

## AUFRUF IM NAMEN VON JURI

Ich, Juri Janovski, fordere Geburtskliniken, Geburtshäuser, Hebammen, Ärztinnen und Ärzte, Forschungseinrichtungen und internationale Gesundheitsorganisationen auf, diese Frage **gemeinsam mit gebärenden Frauen** in transparenten, vorab registrierten und ausreichend großen Studien zu beantworten.

Geburtsräume dürfen nicht allein nach technischer Zweckmäßigkeit gestaltet werden. Selbstbestimmung, Geborgenheit und klinische Sicherheit gehören gemeinsam untersucht und verwirklicht.

## WAS DIE FORSCHUNG HEUTE TRÄGT

WHO: frauenzentrierte, respektvolle und psychologisch wie klinisch sichere Betreuung. · NICE: Musik nach Wahl der Frau unterstützen. · Musik-Reviews: vielversprechend bei Schmerz und Angst, Langzeitwirkung offen. · Raumdesign: positive Signale, klinische Ergebnisse bisher uneinheitlich. · Gedimmtes Licht: eine registrierte Studie prüfte 50-80 Lux; Ergebnisse sind noch nicht veröffentlicht.

Quellen: WHO Intrapartum Care (2018); NICE NG235 §1.6.9; Hunter et al. (2023), 28 RCTs / n=2.835; Nilsson et al. (2020), Birthing Room Design; Lorentzen et al. (2021), RCT; ClinicalTrials.gov NCT07310602; WHO Newborn Thermal Protection.

# THE JURI JANOVSKI THESIS ON BIRTH

Juri Janovski · 9 September 2026

**The best possible maternity care combines a calm, warm, sheltered and dimly lit environment controlled by the woman giving birth - with her chosen music or silence - with immediately available midwifery support and clinical safety.**

**CODE: LOWER PRESSURE | INCREASE AUTONOMY | PRESERVE SAFETY**

## THE QUESTION TO THE WORLD

Does a woman-controlled, low-stimulus birth environment measurably improve **autonomy and birth experience** compared with usual care under equivalent clinical support, without a clinically relevant deterioration in maternal or newborn safety?

### WHAT “BETTER” MUST MEAN

1 · Experience: greater perceived control, shelter and a better birth experience.

2 · Safety: no clinically relevant deterioration for mother or newborn.

Measure anxiety, stress, pain, medication, augmentation, labour duration, interventions, blood loss, injuries, infection, newborn condition, monitoring interruptions and time to necessary intervention. At 6 weeks and 3 months, use validated measures of birth-related distress and depressive symptoms. Necessary clinical care is not a study failure.

### THE WOMAN CONTROLS THE ROOM

Light, sound, music or silence, movement, privacy and chosen companions remain changeable decisions of the woman.

Candles describe the atmosphere: clinical implementation uses dimmable flameless lighting. Examination and emergency lighting remain instantly available. Warmth, monitoring and immediate clinical help are preserved.

## A PUBLIC CALL IN JURI'S NAME

I, Juri Janovski, call on maternity units, birth centres, midwives, physicians, researchers and international health organisations to answer this question **together with women giving birth** through transparent, preregistered and adequately powered studies.

Birth rooms should not be designed only around technical convenience. Autonomy, shelter and clinical safety must be studied and realised together.

## WHAT CURRENT EVIDENCE SUPPORTS

WHO: woman-centred, respectful, psychologically and clinically safe care. · NICE: support music chosen by the woman. · Music reviews: promising for pain and anxiety; long-term effects remain unclear. · Room design: positive signals with inconsistent clinical outcomes. · Dim light: a registered trial tested 50-80 lux; results have not yet been published.

Sources: WHO Intrapartum Care (2018); NICE NG235 §1.6.9; Hunter et al. (2023), 28 RCTs / n=2,835; Nilsson et al. (2020), Birthing Room Design; Lorentzen et al. (2021), RCT; ClinicalTrials.gov NCT07310602; WHO Newborn Thermal Protection.